

CODI SÈPSIA

Un dels principals motius de deteriorament clínic en el pacient són les infeccions. Un cop identificat el malalt amb una puntuació NEWS ≥ 7 , sospitarem que la causa del deteriorament és infecciosa quan el pacient presenti **febre (o sensació d'haver-ne tingut), hipotèrmia no accidental o temperatura normal i un o més dels símptomes següents, o bé deteriorament general sense causa que ho expliqui:**

- Tos, expectoració.
- Molèsties urinàries o dolor en orinar, orina fosca o pudenta.
- Dolor abdominal, diarrees, vòmits.
- Cefalea o alteració de l'estat mental
- Dolor, inflamació i envermelliment de qualsevol extremitat.
- Úlceres cutànies, ferides recents amb supuració o envermelliment, portador de catèter central amb envermelliment del punt d'entrada o sonda vesical permanent.



CECOS: COMUNICACIÓ-ALERTA

Metodologia **IDEAS** per la comunicació estructurada:

I: Identificació del malalt, edat i sexe.
D: Sospita diagnòstica. identificació del símptoma guia.
E: Estat del pacient. Escala de valoració **NEWS**.
A: Actuació sobre el malalt. Tractament i principals accions rellevants.
S: Alerta malalt crític o Activació codi sèpsia, si compleix els criteris.

CRITERIS ACTIVACIÓ CECOS

NEWS: ≥ 7 punts
Criteris d'infecció o Factors de risc d'infecció?

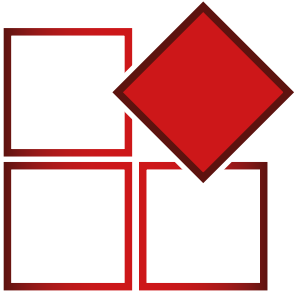
- **Sí:** activar **codi Sèpsia**.
- **No:** trasllat a urgències amb **alerta per malalt crític**.

FACTORS DE RISC D'INFECCIÓ
Diabetis mellitus.
Consum crònic de corticoides o fàrmacs immunosupressors (pacient trasplantat, artritis reumatoide, malaltia inflamàtoria intestinal, etc.)
Immunosuprimits (esplenectomitzats, HIV, hemodiàlisi).
Neoplàsies actives o tractament amb quimioteràpia.
Infecció recentment diagnosticada o en tractament antibiòtic.
Intervenció quirúrgica o endoscòpica (urinària, biliar) en el darrer mes.
Ferides quirúrgiques, úlceres cutànies, portador de catèter venós central (diàlisi, porth-a-cath) o sonda vesical.
Pacient major de 70 anys, amb dependència o en residència.*

**En aquests malalts cal valorar l'estat basal abans d'activar el codi sèpsia o l'alerta per malalt crític.*



codi sèpsia



Atenció d'emergència al malalt crític amb sospita d'infecció greu



Autors: GdT Sèpsia de la Junta Clínica SEM. Gener 2021.



Salut/ emergències mèdiques

MALALT CRÍTIC

Un **malalt en estat crític** és aquell subgrup de pacients greus que evolucionen de forma desfavorable cap a un fracàs multiorgànic.

- Causes més freqüents d'evolució cap a un estat crític**
- Infeccions
 - Problemes cardíacs
 - Problemes neurològics
 - Traumatismes
 - Intoxicacions
 - Al·lèrgies greus

VALORACIÓ INICIAL

La valoració del pacient es realitza de forma ordenada (IDEAS):

- I: Identificació** del malalt.
D: Sospita diagnòstica. Valoració de l'entorn i identificació del símptoma guia.
E: Valoració de l'estat del pacient:
- Primera impressió i ABCDE
 - Descartar críters de risc vital*
 - Escala de valoració NEWS
- A: Actuació** sobre malalt i entorn
S: Definir el **suport**/recursos requerits

*CRITERIS DE RISC VITAL

Seràn pacients amb risc vital, aquells que en presentin, **al menys, un dels següents:**

- A:** afectació de la permeabilitat de la via aèria.
B: afectació respiratòria:
Taquipnea > 30 rpm, bradipnea < 8 rpm (mesurat durant 1 minut).
Treball respiratori, Escala de Patrick >3.

TREBALL RESPIRATORI (Escala de Patrick)	
No utilitza musculatura accésoria	0
Tensió cervical sense enfonsament	1
No utilitza musculatura subcostal	2
Tiratge subcostal marcat	3
Clavícules enfonsades	4
Respiració abdominal	5

- Cianosi, livideses.
C: afectació de la circulació.
TAS < 90 mmHg (o reducció TAS basal > 40%) / TAS > 220mmHg.
FC < 40 bpm, FC > 131 bpm.
D: afectació del nivell de consciència.
Somnolència, estupor, coma, convulsions.

Els valors alterats de forma aïllada d'una constant vital (FC, FR, TAS), s'han d'interpretar segons l'estat general del malalt.

GUIA DE DETECCIÓ EN ADULTS

ESCALA NEWS (National Early Warning Score). Royal College of Physicians 2018.

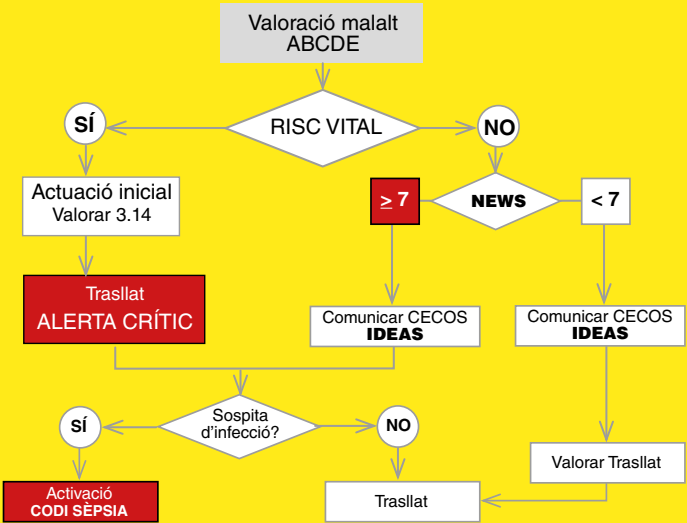
PARÀMETRES FISIOLÒGICS	3	2	1	0	1	2	3
Freqüència respiratòria, FR (rpm)	≤ 8		9 -11	12-20		21-24	> 25
SpO ₂ (escala 1) Escala estàndard	≤ 91	92 -93	94 -95	≥ 96			
SpO ₂ (escala 2) Pacients amb ús de CPAP o BiPAP o d'oxigen crònic domiciliari	≤ 83	84-85	86-87	88-92 ≥ 93 aire	93-94 amb O ₂	95-96 amb O ₂	≥ 97 amb O ₂
Respira aire ambient o oxigen		oxigen					
TAS (mm/Hg)	≤ 90	91 -100	101 -110	111 -219			≥ 220
Freqüència cardíaca, FC (bpm)	≤ 40		41-50	51-90	91 -110	111-130	≥ 131
Nivell de consciència				alerta			inconscient confós desorientat*
Temperatura °C	≤ 35		35.1-36	36.1-38	38.1-39	≥ 39.1	

- Es valora la puntuació obtinguda en la primera valoració o la pitjor puntuació durant l'assistència.
SpO₂ només se'n puntua una (escala 1 o escala 2) - Escala 1: s'utilitza per pacients **sense patologia respiratòria**.
- Escala 2: s'utilitza en lloc de l'Escala 1 per pacients amb ús de **CPAP o BiPAP o oxigen crònic domiciliari**.
- Pacient amb O₂ domicili: Intentar SpO₂ 88-92. Puntua < 88 i > 92.
 - Pacient sense O₂ domicili (respira aire ambient) : puntua < 93.

Un **PACIENT AMB NEWS ≥ 7 ÉS POTENCIALMENT CRÍTIC**. Cal pensar que pot empitjorar en un curt període de temps.

*amb un estat basal conservat

ALGORITME



TRACTAMENT

- Fluids:** Indicats en pacients amb NEWS ≥ 7 i EtCO₂ < 25 mm/Hg, IP 1'4, índex xoc > 0'8 o mala perfusió perifèrica.
Aplicar descàrregues de 500 ml de cristal·loides, preferentment solucions balancejades (Plasmalyte™), monitorar tolerància. **Evitar col·loides.**
Vasopressors: Noradrenalina en perfusió contínua és d'elecció. Dosi màxima 1 mcg/kg/min. Per pacient de 80 kg (8 mg/50 ml de sèrum glucosat inicialment a 3 ml/h fins a màxim 30 ml/h augmentant de 3 en 3 ml/h) fins TAM > 65-70 mm/Hg. Cal monitorar estretament el malalt.
Analgèsia: Orientar al focus infecciós. Analgèsia si dolor segons escala EVA ≥ 5/10 o signes clínics de dolor intens amb 50 mcg de Fentanil + Paracetamol 1g iv.
Insulina ràpida 10 UI sc si hipeclicèmia. Mantenir xifres al voltant de 180 mg/dl durant l'assistència i el trasllat.
Evitar episodis d'hipoglicèmia.

*TAM=TA diastòlica + [(TA sistòlica - TA diastòlica) / 3]

OBJECTIUS
Estat mental normal
TAM 65-70 mm/Hg
EtCO₂ > 25 (35-45)
SpO₂ > 90%
BMT < 180 mg/dl